

DIABETE MELITO TIPO I (DM I)	
Portaria Conjunta SAS/SCTIE/MS nº 17, de 12/11/2019	
Critérios de Inclusão Geral para DM1	Serão incluídos os pacientes com diagnóstico de DM1 que apresentem sinais de insulinopenia inequívoca acrescidos da demonstração de hiperglicemia: → Sinais de insulinopenia inequívoca: sintomas de hiperglicemia (glicemia acima de 200 mg/dL necessariamente associada à poliúria, noctúria, polidipsia, polifagia noctúria e perda de peso inexplicada) ou presença de cetoacidose diabética. → Demonstração de hiperglicemia para diagnóstico de DM: 1. Glicemia aleatória maior do que 200 mg/dL na presença de sintoma: polidipsia, poliúria, noctúria e perda inexplicada de peso; OU 2. Glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg/dL; OU 3. HbA1c maior ou igual a 6,5%; OU 4. Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga ≥ 200 mg/dL.
Medicamento	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA
	ASPARTE
	Pacientes acima de 1 ano.
CID-10	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9
Apresentação	100 UI/mL solução injetável com sistema de aplicação
Inclusão	Para o uso de análogo de insulina de ação rápida, os pacientes deverão apresentar além dos critérios de inclusão de DM1, todas as condições descritas abaixo: → Uso prévio de insulina NPH e insulina regular (por mais de 3 meses); → Pelo menos 1 dos critérios elencados, nos últimos 6 meses: 1. Hipoglicemia grave; 2. Hipoglicemia não grave, por pelo menos 2x na semana; 3. Hipoglicemia noturna, por pelo menos 1x na semana; 4. Mau controle comprovado por HbA1C;
Anexos Obrigatórios	→ Formulário Médico para tratamento de DM 1; → LME; → Receita médica deve conter a dose MÉDIA diária pretendida (Em ui/dia); → Exames comprobatórios: Pelo menos dois (2) dos seguintes exames: 1. Glicemia aleatória maior do que 200 mg/dL; OU 2. Glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg/dL; OU 3. HbA1c maior ou igual a 6,5%; OU 4. Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga maior ou igual 200 mg/dL.
Administração	Em geral, a dose total diária varia de 0,5 a 1 UI/kg/dia. A aplicação deve ocorrer 5 a 15 minutos antes das refeições ou imediatamente após.
Prescrição Máxima Mensal	→ 13 sistemas de aplicação de insulina + → 31 agulhas.
Monitoramento	→ Realização de automonitorização da glicemia capilar (AMG) no mínimo 3x/dia; → Acompanhamento regular (mínimo 2x/ano) com médico e equipe multidisciplinar e sempre que possível com endocrinologista.
Exclusão	→ Insulina análoga de ação rápida - asparte: pacientes com idade inferior a 1 ano; → Pacientes com Diabetes Melito tipo 2;

	→ Pacientes com hipersensibilidade à insulina; → Pacientes que não atendem aos critérios inclusão e manutenção do tratamento.	
Tempo de Tratamento	Indeterminado.	
Medicamento	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA	
	GLARGINA	DEGLUDECA
	Pacientes acima de 2 anos.	Pacientes de 1 a 2 anos.
CID-10	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	
Apresentação	100 UI/mL solução injetável com sistema de aplicação	
Inclusão	Para o uso de análogo de insulina de ação prolongada, os pacientes deverão apresentar além dos critérios de inclusão de DM1, todas as condições descritas abaixo: → Uso prévio de insulina NPH associada a insulina análoga de ação rápida (por mais de 3 meses); → Pelo menos 1 dos critérios elencados, nos últimos 6 meses: 1. Hipoglicemia grave; 2. Hipoglicemia não grave, por pelo menos 2x na semana; 3. Hipoglicemia noturna, por pelo menos 1x na semana; 4. Mau controle comprovado por HbA1C.	
Anexos Obrigatórios	→ Formulário Médico para tratamento de DM 1; → LME; → Receita médica deve conter a dose MÉDIA diária pretendida (em ui/dia) (integrada ao formulário); → Exames comprobatórios: Pelo menos 2 dos seguintes exames: 1. Glicemia aleatória maior do que 200 mg/dL; OU 2. Glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg/dL; OU 3. HbA1c maior ou igual a 6,5%; OU 4. Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga maior ou igual 200 mg/dL.	
Administração	Em geral a dose total diária varia de 0,5 a 1 UI/kg/dia. A aplicação deve ocorrer 1 a 2 x ao dia, no mesmo horário	
Prescrição Máxima Mensal	→ 11 sistemas de aplicação de insulina + → 31 agulhas.	
Monitoramento	→ Realização de automonitorização da glicemia capilar (AMG) no mínimo 3x/dia; → Acompanhamento regular (mínimo 2x/ano) com médico e equipe multidisciplinar e sempre que possível com endocrinologista.	
Critérios de Exclusão	→ Insulina análoga de ação prolongada - degludeca : pacientes com idade inferior a 1 ano e superior a 2 anos; → Insulina análoga de ação rápida - glargina : pacientes com idade inferior a 2 anos; → Pacientes com Diabetes Mellito tipo 2; → Pacientes com hipersensibilidade à insulina; → Pacientes que não atendem aos critérios inclusão e manutenção do tratamento.	
Tempo de Tratamento	Indeterminado.	
Validade dos Exames	Glicemia aleatória; glicemia em jejum; HbA1c; glicemia de 2 horas pós-sobrecarga: 6 meses.	

Especialidade Médica	Novas solicitações	→ Endocrinologista (preferencialmente); → Médico clínico com experiência no tratamento de DM.
	Renovação e Adequação	→ Endocrinologista (preferencialmente); → Médico clínico com experiência no tratamento de DM.

CASOS ESPECIAIS:

1. Diabetes Latente Autoimune em adultos (Latent Autoimmune Diabetes in Adults - LADA):

Para a Diabetes LADA é obrigatório apresentar:

- Diagnóstico de DM1 (critérios de inclusão) E
- **Dosagem de peptídeo C E**
- Pelo menos 1 dos marcadores de autoimunidade (pesquisa e titulação) abaixo:
 - Anti-ICA ou Anticorpo Anti-ilhota de Langerhans,
 - Anti IAA ou Anticorpo Anti-Insulina ou

2. Gestante:

- Os análogos de insulina de **ação rápida**:
 - Asparte (categoria A) pode ser usada na gestação,
 - Lispro (categoria B) pode ser usada com cautela e a
 - Glulisina deve ser evitada (categoria C).
- Os análogos de insulina de **ação prolongada**:
 - Detemir (categoria B) pode ser considerado durante a gravidez.
 - Glargina (categoria C) não conta com estudo clínico controlado envolvendo mulheres grávidas.

3. Lactante:

Considerando que a glicemia materna pode variar muito neste período, faz-se necessária uma monitorização mais frequente da glicemia capilar e correções de doses de insulina e de alimentação antes e após a amamentação. Não foram encontrados estudos randomizados que avaliaram a melhor forma para estes ajustes ou se há tipo preferencial de insulina, devendo-se individualizar os casos.

CID-10:

- E10.0** Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma
- E10.1** Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose
- E10.2** Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais
- E10.3** Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas
- E10.4** Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas
- E10.5** Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas
- E10.6** Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas
- E10.7** Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas
- E10.8** Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas
- E10.9** Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações